UE D1 S1

Savoir être, communication professionnelle et leadership

TD N° 1 : La communication

20 octobre 2026

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Communiquer de manière claire, respectueuse en non stigmatisante et adaptée avec les personnes soignées et leur famille en tenant compte de leur connaissances, leurs besoins et croyances.
- Identifiez les principes de la communication dans les soins infirmiers.
- Différenciez la communication verbale et non verbale.
- Citez les conditions d'une communication efficace (attitudes facilitantes et obstacles).

Compétences

- Etablir une relation adaptée à une personne ou un groupe de personne pour une prise en soin de qualité en mobilisant les compétences psycho-sociales

LE CONCEPT DE COMMUNICATION



Introduction

Qu'évoque pour vous le mot « communication » ?



Le concept de communication

Quelle différence faites-vous entre « parler » et « communiquer » ?



Le concept de communication

- ✓ parler » = latin *parabolare*, de *parabola*, parole
  - Émettre les sons articulés d'une langue naturelle.
  - Utiliser la parole pour exprimer sa pensée, ses idées,….

- ✓ « COM » = « avec », art d'être « en relation »

« communication », du latin *communicare* = mettre en commun, partager, être en relation avec quelqu'un, transmettre des informations

- « Communiquer » est l'aptitude d'une personne à entrer en relation avec l'autre et à avoir des échanges avec elle
- Cela implique une posture juste, acceptable et un comportement professionnel

= « Parler pour communiquer » ou « communiquer en parlant »

= il est possible de « communiquer » sans « parler »

Le concept de communication

Définition « communication » :

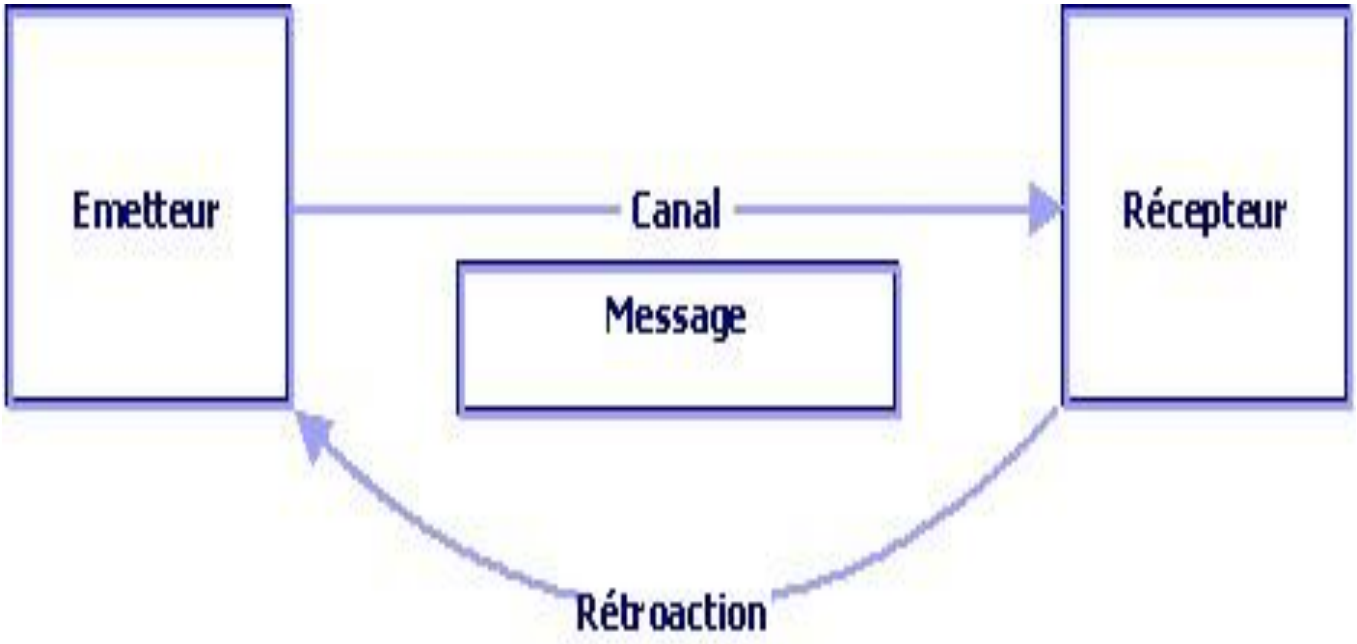
Processus cognitif, social et affectif entre deux ou plusieurs individus, dans le but de transmettre une information, une émotion, convaincre, faire agir l'autre.

➢ **« On ne peut pas ne pas communiquer »** *car il y a toujours une communication quelque soit le mode :*

- ✓ **Verbal =** utilisation des mots : 7%
- ✓ **Paraverbal =** intonation de la voix : 38%
- ✓ **Non verbal =** utilisation des gestes, mimiques,… : 55%

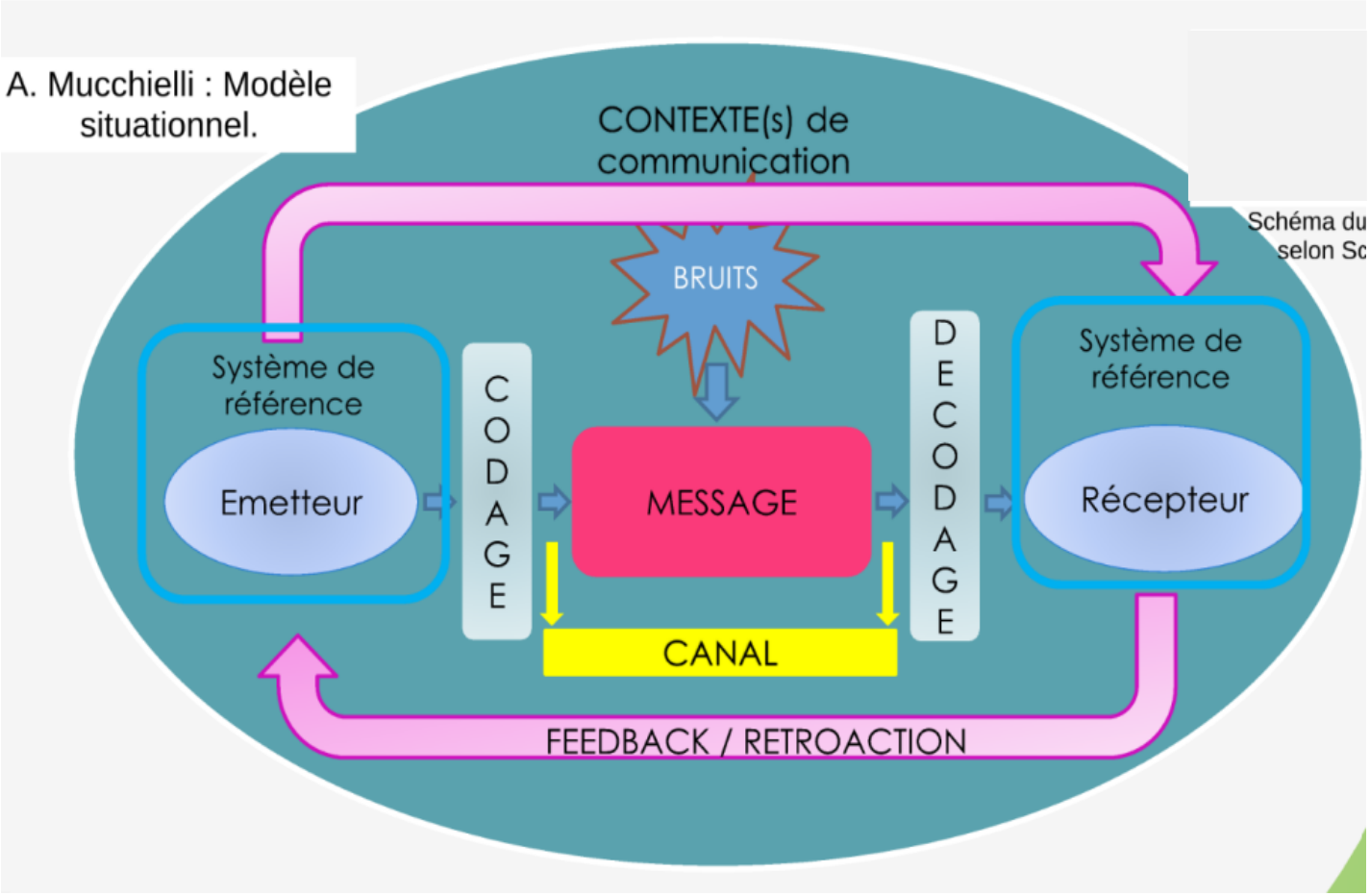
(règle des 7/38/55 de Albert Mehrabian)

Schéma simplifié de la communication



ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

Schéma de la communication



Explication du schéma simplifié de la communication

Emetteur : ses caractéristiques peuvent influer sur l'efficacité de sa communication (selon sa crédibilité et son attractivité). Pour envoyer son message il utilise un canal.

Canal : auditif (l'air, le téléphone, un message vocal) ou visuel (la télé, un affichage, une note, un mail) = son choix n'est jamais neutre.

Message : importance du fond et de la forme. Son efficacité dépend de sa complexité (vocabulaire simplifié ou professionnel), du degrés d'implication de l'émetteur (illustrations par des exemples +ou- personnels), de la proximité de la source (message transféré moins fiable que le message direct)

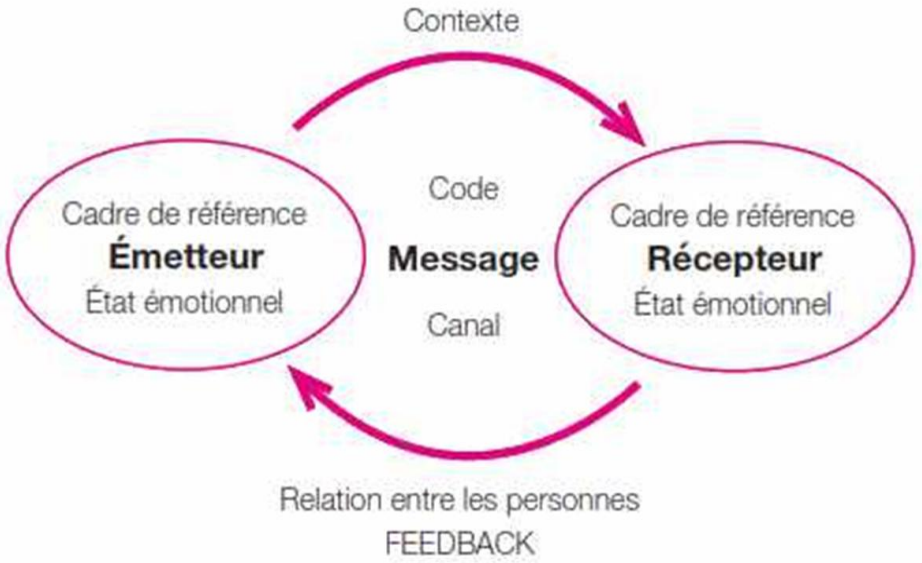
Récepteur : il doit désirer communiquer et avoir des capacités de décodage du message (références communes comme : l'humour, le vocabulaire, la langue, les avis,...). Il va réagir au message reçu = c'est le feed-back verbal ou non verbal

Rétroaction ou feed-back : elle va permettre à l'émetteur de vérifier la bonne réception du message et cerner comment ce message a été compris.

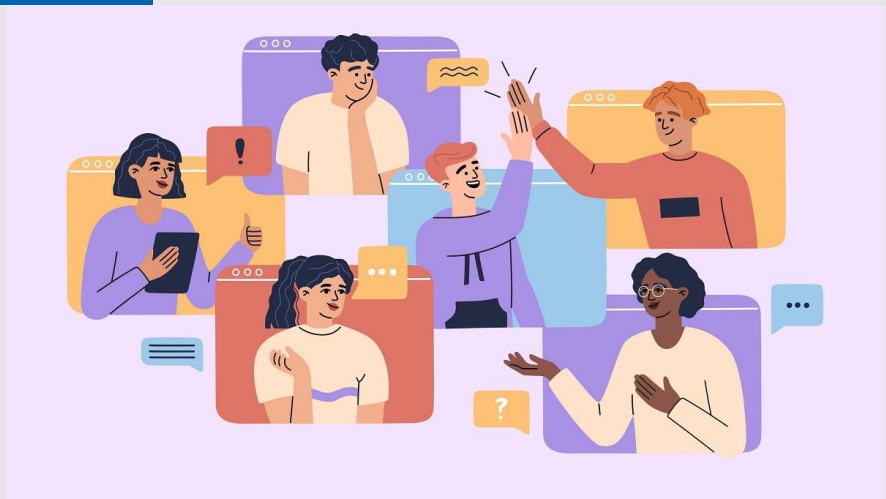
Les freins à la communication

D'autres éléments s'ajoutent à ce schéma de la communication :

- **Les perturbateurs (Bruits et absence de contact entre Emetteur et Receveur)**
- **L'état émotionnel**
- **Les filtres**

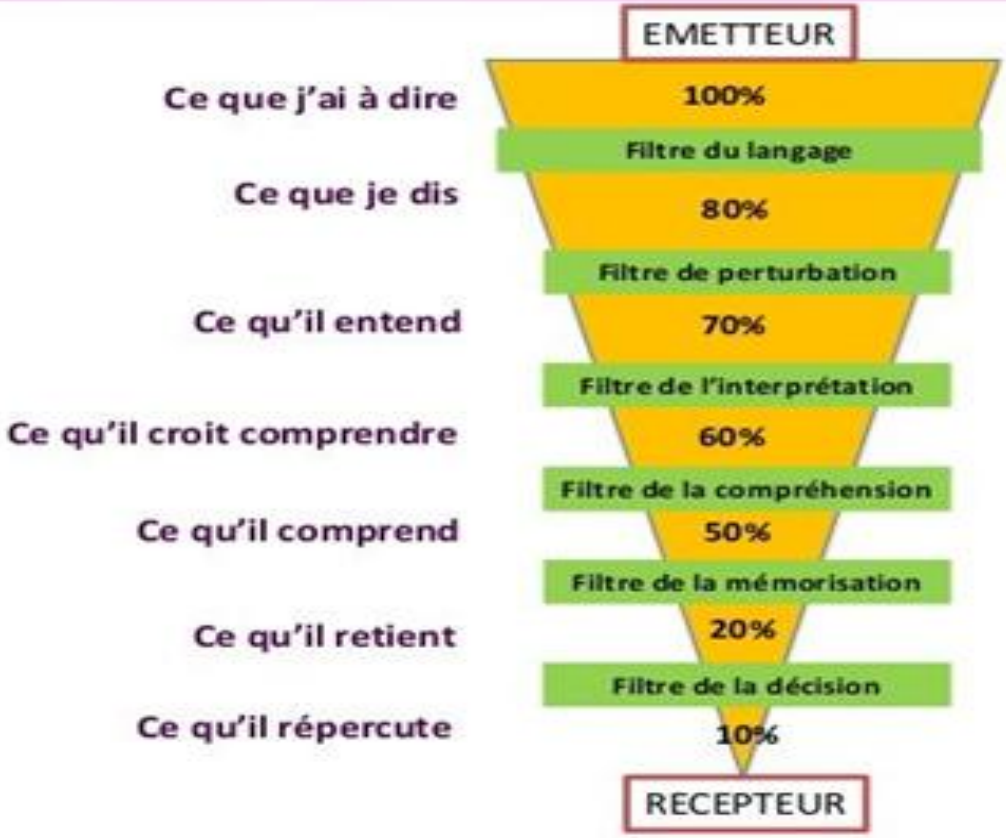


2 LES FILTRES DE LA COMMUNICATION



Les filtres dans la communication

Entonnoir de communication



openity

Les filtres dans la communication

- ✓ Le message va passer à travers plusieurs filtres en lien avec : **les expériences, les émotions, les représentations, les cultures**

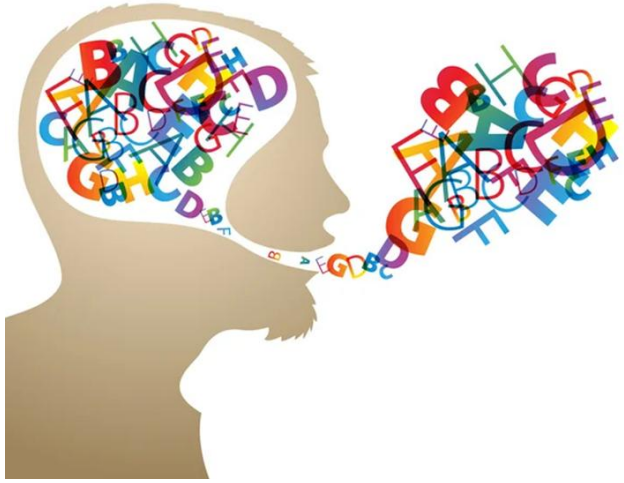
- ✓ Ils peuvent influencer le message et le modifier

  → **Message émis ≠ message à transmettre**

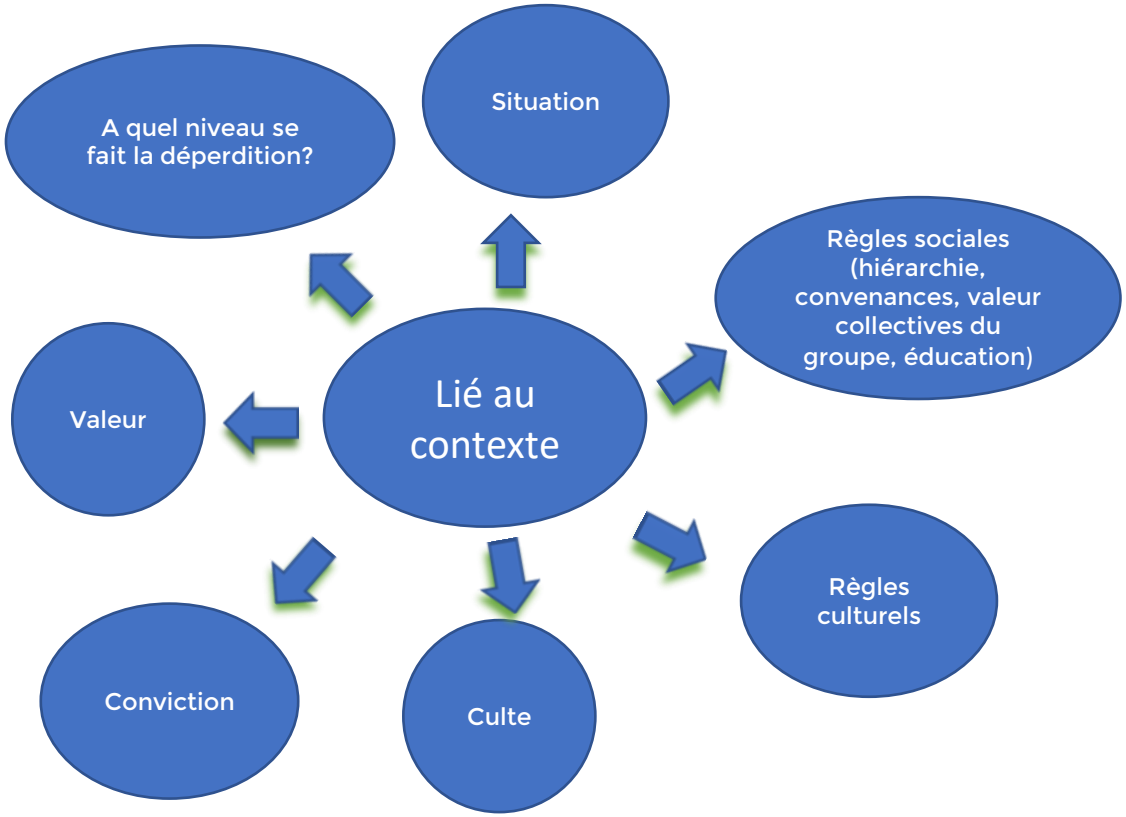
- ✓ Ils modifient la nature du message : risque d'interprétations

Les filtres dans la communication

Quels sont les contextes qui engendrent une déperdition d'informations lors de la communication ?



Les filtres liés au contexte



Nécessité de clarifier la compréhension car la déperdition d'informations se fait à différentes étapes

Les filtres liés aux personnes

Quels sont les filtres liés aux personnes lors de la communication?



Les filtres liés aux personnes

Les filtres et leur fonctionnement sont propres à chaque individu.

- Ils sont le résultat d'un mélange de normes, d'usages, d'éducation, de croyances, de personnalité, de ressentis et d'émotions.

- *Par exemple :*

  On ne communique pas forcément de la même manière dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle

  Notre manière de communiquer change selon notre état d'esprit.

  On ne perçoit pas les messages de la même manière selon les contextes, les interlocuteurs, etc.

Comment limiter l'impact des filtres ?

- ✓ Pour **limiter les filtres de l'émetteur** :
  - préparer le message avant de le délivrer et la façon de l'exprimer

- ✓ Pour **limiter les filtres au moment des échanges** :
  - choisir un environnement adapté à la communication, adapter la tonalité de voix, s'assurer que l'interlocuteur est attentif

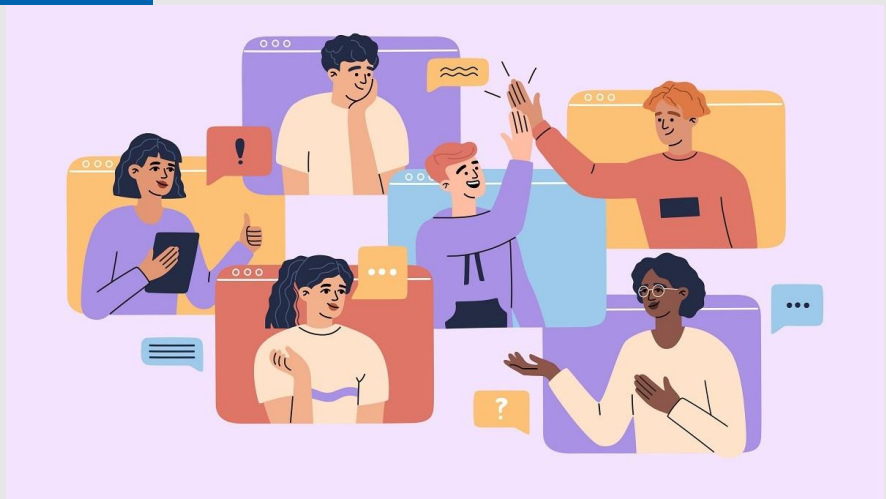
- ✓ Pour **limiter les filtres du récepteur** :
  - repérer ce que l'interlocuteur accepte du message, ce qu'il semble avoir retenu et ce qu'il va en faire

Comment limiter le risque de déformation du message ?

Les émotions ont un pouvoir de déformation du message :

- En avoir conscience permet de limiter les déformations liées à l'affect de certains messages.
- Même si les émotions ne sont pas liées au contexte ou au message elles peuvent engendrer une déformation du message.

3 LA COMMUNICATION AVEC L'AUTRE



La communication verbale et non verbale



La communication verbale

« Que l'on parle ou non, on communique »

- ✓ Elle **passe par les mots.**
- ✓ Les composantes de la communication **para verbale** :
  - volume de la voix
  - timbre
  - tonalité
  - le débit
  - Intonation
  - articulation
  - Accent marqué, pause
  - sont des **indicateurs d'émotions**.



= la musicalité de la voix et de ses énoncés est **indispensable pour donner du sens** . On parle de **prosodie.**

Les composantes **verbales sont aussi des indicateurs d'émotions** de la personne qui s'exprime.

La communication non verbale

Elle est instinctuelle, quelquefois difficile à contrôler mais authentique.





Il est nécessaire pour le soignant d'apprendre à gérer ses émotions.

La communication non verbale

Elle s'exprime par :



- ✓ Le **contact visuel** : démontre l'intérêt
- ✓ Les **mimiques faciales** : le sourire est un vecteur de communication mais il est à adapter aux situations.
- ✓ La **posture et la gestuelle** indiquent la **disponibilité**.



La communication non verbale

Organisée par 5 grands thèmes :

- ✓ **Le territoire** = la proxémie (=*juste distance, respect de l'espace intime*) dépend de la culture, des coutumes du pays d'origine

- ✓ **La posture** = le tonus, les gestes, le contact corporel (ex : *gestes affectueux*)

→en avoir conscience pour **éviter une relation « dominant-dominé »** avec la personne soignée

La communication non verbale

- ✓ **L'image corporelle** = le choix vestimentaire (*selon son groupe d'appartenance, sa culture, la mode*), la coiffure,…

- ✓ **Le visage et la mimique** = apportent une infinité de micros-expressions inconscientes (*importantes pour le feed-back*)

Les indices corporels :

= sont des signes non équivoques du feed-back (*ex : hochement de tête pour dire « oui »)*

- ✓ **Le ton de la voix** = modulé en fonction de l'interlocuteur (*ex : ton ferme pour se faire écouter, ton posé et calme pour rassurer).*

La communication non verbale

Effets de la communication non verbale :

- ✓ Le message a un **impact supérieur** s'il y a concordance entre texte et attitude
- ✓ Le message discordant suscite le malaise et entrave la mémorisation (s'il est répété plusieurs fois, le sens du message peut disparaître)
- ✓ L'attitude de **neutralité** rend le message **inopérant**

La communication, ce qu'il faut retenir



- ✓ Elle peut être à la fois **verbale et non verbale**
- ✓ Le **choix des mots** est important pour éviter les malentendus.
- ✓ Bannir les préjugés et les stéréotypes qui pourraient se glisser dans un message
- ✓ Apprendre à **maîtriser ses émotions** dans la communication pour les adapter à la relation de soin
- ✓ Avoir conscience des **indices corporels** pour garantir une relation symétrique et authentique avec la personne soignée

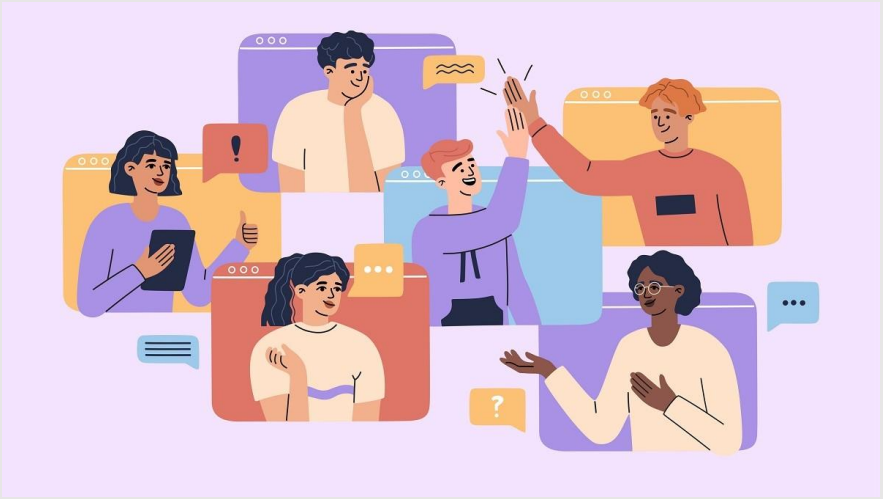
TEMPS 2 : Travail de groupe.

1. Qu'est-ce que pour vous une **communication adaptée à la personne soignée** ? Sur quoi repose-t –elle ?

2. Quelles sont les **attitudes chez le soignant qui facilitent la communication** dans les soins ?

3. Quels sont les **obstacles qui peuvent nuire à la communication** dans les soins ?

4 LA COMMUNICATION ADAPTEE AVEC LA PERSONNE SOIGNEE



La communication adaptée à la personne soignée

L'IDE doit montrer une **adéquation entre le verbal et le non verbal**

= Congruence

L'IDE conduit une **démarche de communication adaptée** aux personnes et à leur entourage en :

- ✓ Identifiant les besoins et les demandes de la personne
- ✓ Adaptant sa communication au niveau de **compréhension** de la personne.
- ✓ Quelles sont ses attentes? Ses envies ?
- ✓ Quelles sont ses aptitudes psychologiques (ex : mécanisme de défense) et ses capacités cognitives (présence ou non de pathologie engendrant des troubles cognitifs) ?

La communication adaptée à la personne soignée

Pour **adapter la communication**, l'infirmier(ière) s'interroge sur :

- ✓ **Les buts de la relation** en lien avec les attentes de la personne
- ✓ **Le choix du langage** pour qu'il soit :
  - adapté aux capacités de compréhension et de réceptivité de la personne
  - adapté à sa volonté ou à sa force pour maintenir la relation

Les circonstances : lieu, moment, position dans l'espace (ex : IDE debout et malade couché), présence d'autres personnes,...

La communication adaptée à la personne soignée

- ✓ **DISPONIBILITE**
- ✓ **ATTENTION à l'Autre**
- ✓ **OBSERVATION:**
- ✓ **REPERER**

  - **Repérer la manière de communiquer**
  - **Repérer les aptitudes à comprendre**
  - **Repérer ses capacités de mémorisation**
  - **Evaluer la fonction sensorielle de la personne**

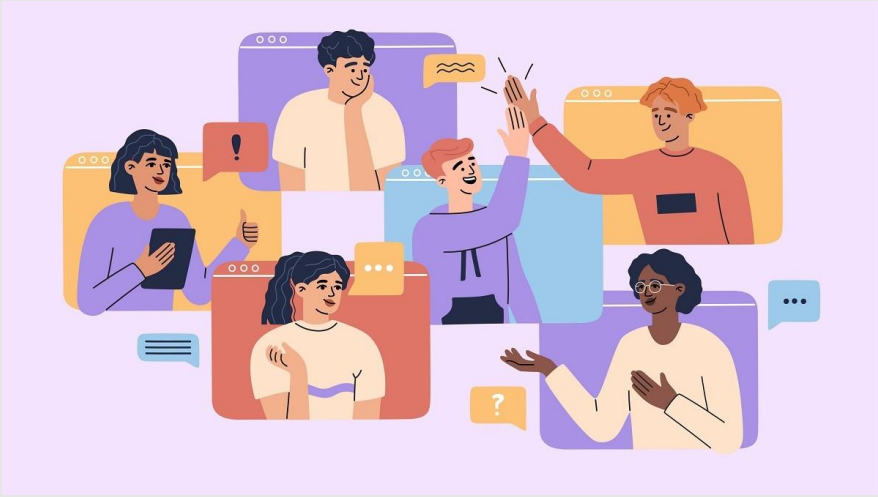
Ce qu'il faut retenir …



La communication dans la relation de soins sera effective si :

- ✓ la communication **verbale et le non verbale** du soignant sont en **adéquation = congruence**
- ✓ Le soignant s'adresse à la personne soignée, en tenant compte de sa **personnalité**
- ✓ Le soignant évalue en amont **les capacités cognitives et sensorielles** de la personne à recevoir et à comprendre le message
- ✓ le soignant s'assurer si les **conditions matérielles sont adaptées**

5 ATTITUDES FACILITANTES ET OBSTACLES AVEC LA PERSONNE SOIGNEE



Les attitudes soignantes qui facilitent la communication avec la personne soignée.

S'assurer des **conditions matérielles :**

- **Lieu approprié** (permet l'expression, la confidentialité)
- **Installation et positions** respectives (permettant une relation adaptée),
- **Retrait** des éléments **parasites** (téléphone portable, inconfort)

Les attitudes soignantes qui facilitent la communication avec la personne soignée.

Pour s'adresser à l'autre, en tenant compte de sa personnalité, de ses capacités à recevoir et à comprendre le message, il est important de :

- ✓ Adresser un **message clair**
- ✓ Utiliser le ou les **langages appropriés** (verbal et non verbal)
- ✓ **Respecter le temps de réception** du message
- ✓ Utiliser **le feed-back** pour vérifier la réception et poursuivre la relation

Les attitudes facilitantes de l'IDE

- ✓ Être **accueillant**
- ✓ Se rendre **disponible**
- ✓ Respecter **la distance relationnelle** ou **juste présence** en fonction des soins.
- ✓ Être **authentique / congruent**
- ✓ Être **empathique**
- ✓ Être objectif
  - ✓ **Respecter les silences**
  - ✓ Utiliser le feed back ou **reformulation**

Les obstacles à la communication en lien avec le message

- ✓ Message **trop riche** (phrases trop longues, termes techniques, médicaux).
- ✓ Message **incomplet** (termes abrégés, sous entendus…).
- ✓ Message **complexe**, sans redondance, sans feed back.
- ✓ Manque d'implication en utilisant le « **on** ».



Les obstacles à la communication en lien avec l'attitude soignante

- ✓ Donner des **solutions, des ordres**.
- ✓ Emettre des **jugements, critiques, interprétations**.
- ✓ Banaliser, **minimiser** pour rassurer ou consoler.
- ✓ **Manquer d'authenticité**
- ✓ Se montrer **indifférent, non disponible…**





- ✓ **Timing inopportun**
- ✓ **Configuration des locaux ne permettant pas la confidentialité** (couloir, porte ouverte…)
- ✓ **Nuisances sonores**, discussions croisées, télévision
- ✓ **Interruption** de l'entretien (téléphone, entrées/sorties dans la pièce…)
- ✓ Les **interférences** olfactives, visuelles, lieu surchauffé ou trop froid…
- ✓ **Asymétrie** entre l'IDE et le patient et installation inconfortable

MERCI DE VOTRE ATTENTION